

TEMA 3.38 • OBSTETRICIA

Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo

PERFIL EUNACOM 3.01.2.012
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo

Definiciones

TABLA 3.38.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	PARTO PREMATURO	RPM / RPO
Definición	Parto 22–36 sem 6 días	Rotura de membranas antes del inicio del trabajo de parto
Pregunta clave	¿ Freno o dejo evolucionar?	¿ Interrumpo o manejo expectante?
Tocolíticos	Sí (< 34 sem)	Contraindicados (= absoluta en EUNACOM)
≥ 34 semanas	Dejar evolucionar	Interrumpir
< 34 semanas	Frenar + madurar	Conducta expectante + corticoides + ATB

Factores de Riesgo (comunes)

- **Parto prematuro previo** (más importante)
- RPM previa pretérmino
- **Cuello corto** (< 25 mm en screening)
- Sobredistensión uterina: gemelos, polihidramnios, macrosomía
- Infecciones: vaginosis bacteriana, pielonefritis, infección intraamniótica
- Tabaquismo, metrorragias del 2º–3er trimestre

Complicaciones

Parto prematuro

- **Solo fetales:** EMH, hemorragia periventricular, enterocolitis necrotizante, muerte, secuelas neurológicas (todos < 34 sem, se previenen con corticoides)

RPM

- **Fetales:** prematuréz, sepsis neonatal, hipoplasia pulmonar (oligoamnios) - **Maternas:** corioamnionitis, endometritis, sepsis - Desprendimiento de placenta ex vacuo - Malformaciones por oligoamnios (compresión)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Respecto a Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Definiciones
- Factores de Riesgo (comunes)
- Complicaciones
- Parto prematuro
- | |---|---|---| | Definición | Parto
- | Rotura de membranas
- | | Pregunta clave | ¿

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PARTO PREMATURO VS. RPM — PARALELO)

PREGUNTA 1

Respecto a Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Parto Prematuro vs. RPM — Paralelo. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PARTO PREMATURO VS. RPM — PARALELO